

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE: LUIS GABRIEL ZUBIRIA QUIÑONEZ	H.C: 1091364684
EDAD: 13 Años 7 meses	FECHA DE NACIMIENTO: 13/01/2012
ESCOLARIDAD: Octavo Grado	FECHA DE EVALUACIÓN: 29/30/08/2025 – 01/09/2025
DIRECCION: Calle 8 # 26A 25 Aguachica	CORREO: jairo.zujiria@gmail.com
EPS:	SEXO: M
ACOMPANANTE: Padres	CELULAR: 3174114439
LATERALIDAD: Diestra	NEUROPSICÓLOGO EVALUADOR: M.G Jainer Guzmán
ESPECIALIDAD QUE REMITE: Neurología	

MOTIVO DE CONSULTA

Madre refiere, estamos en proceso de separación, mi mayor anhelo es que Luis tenga una mejor relación con el padre.

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución desde los primeros años de vida caracterizado por dificultades para relacionarse con niños (masculino), se siente excluido, madre agrega que el menor refiere que le caen mal los niños, la relación con el padre se ha deteriorado, la madre lo describe como un niño muy inteligente pero se distrae mucho, se queda en dictado, no escribe todo, no se entiende lo que escribe, presenta comportamientos agresivos aproximadamente desde el 2018, ha mejorado la intensidad y frecuencia, antes lloraba por todo, le cuesta integrarse con otras personas, debe tener un poco de confianza, sentirse en calidez para poder interactuar, es bilingüe, le gusta vestir de negro, no come pollo guisado, las uvas pasas, (agrega que la salsa le parece asquerosa).

Le molestan los ruidos como los que hacen con el icopor, si se golpea la madera, música con volumen alto, poco contacto visual, habla entre los dientes en consulta, madre refiere que no lo hace en otros contextos.

I. HISTORIA PERSONAL

PRENATALES: No embarazo previo, asistió a controles, embarazo sin riesgo, madre y padre no toman licor, no cigarrillo, no alucinógenos, adecuada alimentación, no auto medicación, no golpe abdominal o caída, no alteraciones en estado de ánimo, no enfermedades médicas.

PERINATALES: Embarazo a término de 39 semanas de gestación por cesárea, (no) utilización de fórceps, (no) maduración de pulmones en el útero, (no) hipoxia perinatal, no cianosis, (no) meconio, (no) sufrimiento fetal, (no) permaneció en incubadora.



II. DESARROLLO PSICOMOTOR

POSNATALES: Control cefálico 3 meses, rolado 5 meses, sentado 6 meses, gateo a los 6 meses, patrón recíproco, bipedestación 12 meses, marcha 12 meses, (si) reacción a los sonidos, (si) fijación de la mirada, lenguaje no funcional, reporte peso al nacer 54 kg, no reporte de talla 4000 Kg.

III. DESARROLLO DEL LENGUAJE

Balbuceo: 7 meses

Primeras palabras: 9 meses

Frases: 24 meses.

Oraciones: 24+ meses.

IV. ABC

Come solo: 12 meses

Se baña solo: 3 años

Se viste solo: 5 años

Higiene personal: 5 años

Control de esfínteres: 2 años

V. ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta

Alcoholismo: No reporta

Drogadicción: No reporta

Epilepsia: No reporta

Autismo: No reporta

TDAH: No reporta

Esquizofrenia: No reporta

VI. ANTECEDENTES PERSONALES

ENFERMEDAD MEDICA: NO REPORTA.

Quirúrgicos: NO.

Tóxicos: NO.

Hospitalizaciones: NO.

Inmunizaciones: Si.

VII. HISTORIA DEL DESARROLLO

MOTOR: Normal.

LENGUAJE: No fluido

ADAPTATIVO: Anormal.

Comunicación, lenguaje y conversación concretos e inmaduros (no), Dificultad en la regulación de las emociones y el comportamiento (no), comprensión limitado del riesgo en situaciones sociales (no), juicio social inmaduro (no), es fácilmente manipulado por otros (no). [0/6]

(No) Dependencia en las actividades de la vida diaria.



VIII. HISTORIA ESCOLAR

Paciente quien cursa octavo grado, no le gusta copiar, se queda en dictado, disortografía, pasa con rendimiento regular, el semestre pasado niveló inglés por no presentar examen, se levanta del puesto de trabajo, logorrea, antes tenía comportamientos agresivos, no se integra con los compañeros del sexo masculino.

IX. HISTORIA FAMILIAR

Familia compuesta por madre, hijo, un perro y dos gatos, relaciones funcionales con la madre, relaciones distantes, conflictivas y agresivas del padre hacia el hijo y expareja, con antecedente de agresión del 1/05/2024 y 12/12/2024, cuando convivía con el padre no lograba tener relaciones funcionales con el padre, conflictos con el padre y ruptura después de agresión por parte del padre.

X. HISTORIA SOCIAL

Reside en casa, antes lloraba cuando salía a la calle, prefiere estar encerrado, le gusta planear las salidas, si sale sin planificar se molesta, se muestra retraído, poco expresivo, se comunica de forma funcional con la madre, responde lo que se le pregunta pero no es capaz de establecer una conversación fluida.

XI. HISTORIA SOCIOAFECTIVA

Paciente con bradipsiquia, bradilalia, poca facilidad de contacto, no hace contacto visual, evita relacionarse con compañeros de clase del género masculino, tuvo un amigo pero ahora refiere que le está empezando a caer bien, alta empatía, pero con hiponimia.

XII. CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

Paciente con adecuada presentación personal, adecuada higiene postural, orientado a lo y orientado auto psíquicamente, no contacto visual, distractivo, no trastornos del lenguaje: si problemas en la escritura, lenguaje fluido pero no espontáneo, bradipsiquia, bradilalia, agitación motora, no quejas de memoria y aprendizaje.

ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER PARA NIÑOS (WISC V)

Rango percentil	Clasificación
130	Muy superior
120 - 129	Superior
110 - 119	Promedio alto
90 - 109	Promedio
80 - 89	Promedio bajo
70 - 79	Inferior
55 - 69	Discapacidad leve
40 - 54	Discapacidad moderada





ESCALA DE INTELIGENCIA
DE WECHLER PARA NIÑOS - V

Cuadernillo de anotación

Cálculo de la
edad
cronológica

Año	Mes	Día
2025	9	1
2012	1	31
13	7	0

Nombre del niño: LUIS GABRIEL ZUBIRIA QUIÑÓNEZ
Examinador: JAINER GUZMÁN VEGA

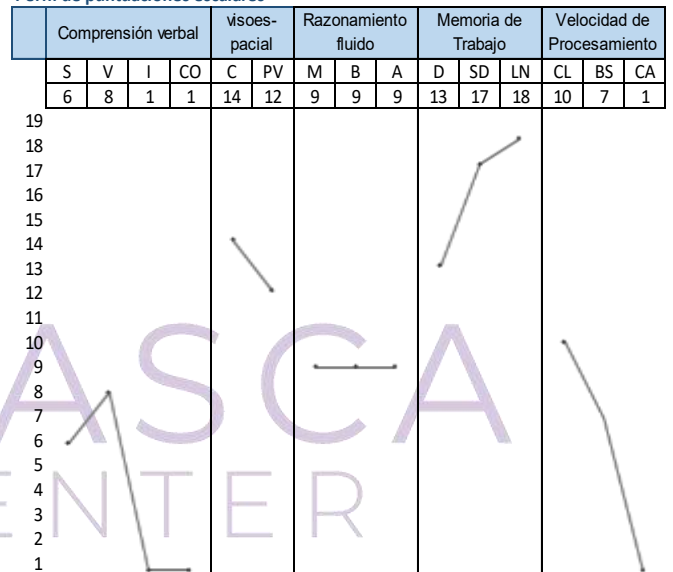
Fecha de aplicación
Fecha de nacimiento
Edad Cronológica

Página de resumen

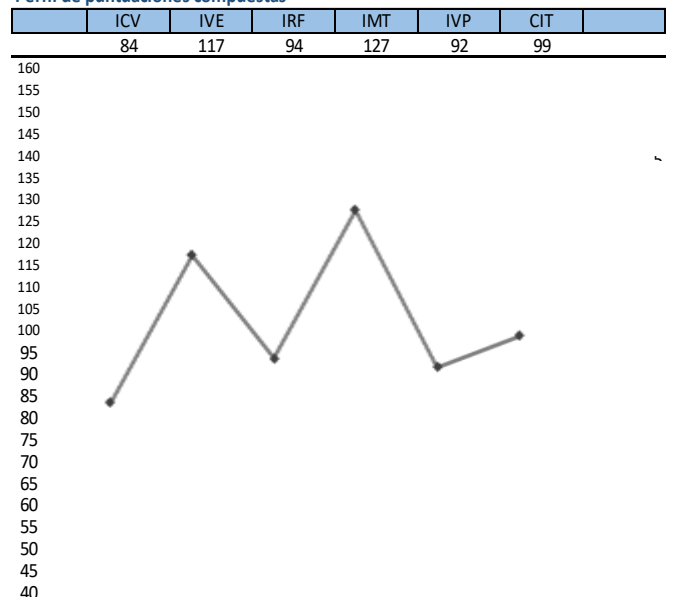
Conversión de puntuaciones directas a puntuaciones escalares

Prueba	PD	Puntuación escalar					
Cubos	44		14				14
Semejanzas	24	6					6
Matrices	19			9			9
Dígitos	32				13		13
Claves	62					10	10
Vocabulario	31	8					8
Balanzas	22			9			9
Puzles visuales	20		12				(12)
Spam de dibujos	44				17		(17)
Búsqueda de Símbolos	23					7	(7)
Información							(1)
Letras y números	25						(18)
Cancelación							(1)
Comprensión							(1)
Aritmética	21						(9)
Suma puntuaciones escalares		14	26	18	30	17	69
		Comp. Verbal	Visoes-pacial	Razon. Fluido	Mem. Trabajo	Vel. Proces.	Escala total

Perfil de puntuaciones escalares



Perfil de puntuaciones compuestas



Conversión de suma de puntuaciones escalares a puntuaciones compuestas

Escala	Suma punt. escalares	Puntuación compuesta		Rango Percentil	Intervalo de confianza 95%
Comprensión Verbal	14	ICV	84	14	77-94
Visoespacial	26	IVE	117	87	107-124
Razonamiento fluido	18	IRF	94	34	87-102
Memoria de trabajo	30	IMT	127	96	117-133
Velocidad de procesamiento	17	IVP	92	30	84-102
Escala total	69	CIT	99	47	93-105

CENTRO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGÍA, ASISTENCIA INTEGRAL Y REHABILITACIÓN

DIR: CALLE 11 # 11 – 07 BARRIO SAN JOAQUÍN LOCAL 102

CONTACTOS: 312 567 8078 – prascacenter@gmail.com

Análisis Primario

Puntos fuertes y débiles						Punto fuerte o débil
		Puntuación	Puntuación de comparación	Diferencia	Valor crítico	
Indices	ICV	84	- 102,8	= -18,8	9,62	F o D
	IVE	117	- 102,8	= 14,2	10,7	F o D
	IRF	94	- 102,8	= -8,8	9,98	F o D
	IMT	127	- 102,8	= 24,2	9,62	F o D
	IVP	92	- 102,8	= -10,8	11,97	F o D
Pruebas	Semejanzas	6	- 10,5	= -4,5	2,86	F o D
	Vocabulario	8	- 10,5	= -2,5	2,94	F o D
	Cubos	14	- 10,5	= 3,5	3,46	F o D
	Puzles visuales	12	- 10,5	= 1,5	2,94	F o D
	Matrices	9	- 10,5	= -1,5	2,94	F o D
	Balanzas	9	- 10,5	= -1,5	2,68	F o D
	Dígitos	13	- 10,5	= 2,5	2,31	F o D
	Span de dibujos	17	- 10,5	= 6,5	3,03	F o D
	Claves	10	- 10,5	= -0,5	3,09	F o D
	Búsqueda de símbolos	7	- 10,5	= -3,5	4,08	F o D



Opciones de comparación de los índices

Puntuación de comparación			
Suma de puntuaciones de los 5 índices primarios			
MIP	514	/ 5	102,8
Nivel de significación del valor crítico			

Opciones de comparación de las pruebas

Puntuación de comparación			
Suma de puntuaciones escalares de las 10 pruebas principales			
MPE-P	105	/ 10	10,5

Comparación entre índices/pruebas

Comparación		Puntuación 1	Puntuación 2	Diferencia	Valor crítico	Diferencia significativa
Indices	ICV-IVE	ICV 84	- IVE 117	= -33	11,28	S o N
	ICV-IRF	ICV 84	- IRF 94	= -10	10,72	S o N
	ICV-IMT	ICV 84	- IMT 127	= -43	10,44	S o N
	ICV-IVP	ICV 84	- IVP 92	= -8	12,30	S o N
	IVE-IRF	IVE 117	- IRF 94	= 23	11,54	S o N
	IVE-IMT	IVE 117	- IMT 127	= -10	11,28	S o N
	IVE-IVP	IVE 117	- IVP 92	= 25	13,02	S o N
	IRF-IMT	IRF 94	- IMT 127	= -33	10,72	S o N
	IRF-IVP	IRF 94	- IVP 92	= 2	12,54	S o N
	IMT-IVP	IMT 127	- IVP 92	= 35	12,30	S o N
Pruebas	Semejanzas-Vocabulario	S 6	- V 8	= 1	2,93	S o N
	Cubos-Puzles visuales	C 14	- PV 12	= 2	2,77	S o N
	Matrices-Balanzas	M 9	- B 9	= 0	2,29	S o N
	Dígitos-Span de dibujos	D 13	- SD 17	= -4	2,48	S o N
	Claves-Búsqueda de símbolos	CL 10	- BS 7	= 3	3,04	S o N

Opciones de comparación de los índices

Nivel de significación del valor crítico			
Grupo de referencia			
Nivel de aptitud			

Opciones de comparación de las pruebas

Nivel de significación del valor crítico			
--	--	--	--

La Capacidad Intelectual Total (CIT), es un indicador de la relación entre los cuatro índices en los cuales se encuentran agrupadas las 10 subpruebas. Para obtener el CI total se utilizan siete de la diez pruebas (Cubos, semejanzas, matrices, dígitos, claves, vocabulario, balanzas). El paciente obtuvo un CIT de **99**, lo que lo ubica en un rango dentro del promedio para su edad y nivel escolar.

Comprensión verbal

El valor obtenido en CV es de **84**, lo cual establece una capacidad **media baja**, estando un rango por debajo de lo esperado con respecto a su edad y escolaridad. Lo cual representa la capacidad para utilizar la información previamente aprendida, la experiencia educativa informal y formal, así como repertorios lingüísticos, manejo de analogías y análisis de relación.

Razonamiento visoespacial o perceptivo

El valor obtenido en RP es de **117**, se clasifica con una capacidad general **promedio alta**, ubicándose un rango por encima del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. El índice de razonamiento perceptivo incluye el razonamiento espacial y la integración visomotora, procesos viso perceptuales y visos constructivos, así como razonamiento abstracto. De esta manera se identifican capacidades para analizar y sintetizar estímulos visuales, para categorizar, clasificar, dar juicios analógicos y razonamientos seriales dando cuenta de forma verbal.

Razonamiento fluido

El valor obtenido es de **94**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándolo dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. Este índice mide la capacidad cognitiva innata del paciente para procesar nueva información, relaciones conceptuales subyacentes entre objetos visuales y usar el razonamiento inductivo y cuantitativo a fin de identificar y aplicar reglas.

Memoria de Trabajo

El valor obtenido en MT es de **127**, se clasifica con una capacidad general **superior**, ubicándose dos rangos por encima del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. El índice de la memoria de trabajo (MT) es una medida de la memoria a corto plazo reflejando la capacidad para retener temporalmente en la memoria cierta información, trabajar con ella y generar resultados, implicando razonamiento, concentración, control mental; aptitud para registrar, mantener y manipular información presentada verbalmente.

Velocidad de procesamiento

El valor obtenido en VP es de **92**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándolo dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. En esta prueba se mide la relación entre tiempo y tarea, capacidad de discriminación, de focalización de la atención y selección de estímulos visuales. Se encuentra capacidad para aparear información simple y para reconocer visualmente información en un periodo de tiempo determinado.

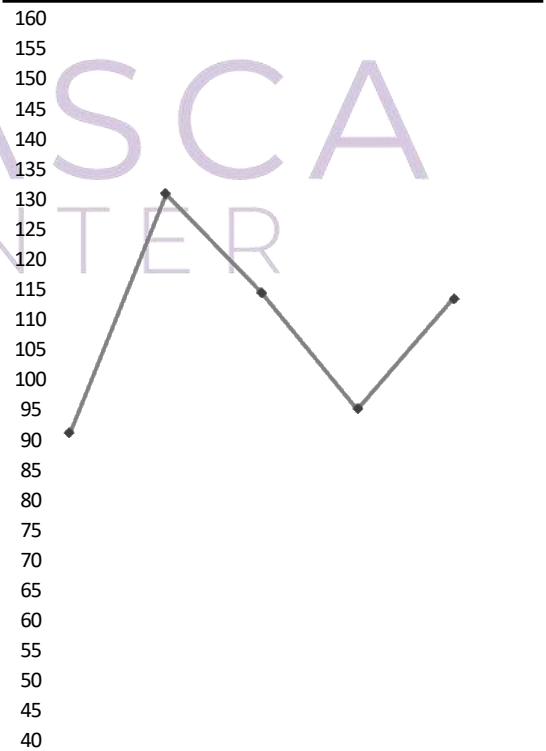




Análisis Secundario					
Suma de puntuaciones escalares					
Pruebas	Puntuación escalar				
Cubos			14	14	
Semejanzas				6	
Matrices			9	9	
Dígitos		13			13
Claves			10		10
Vocabulario				8	
Balanzas	9		9	9	
Puzles visuales			12		
Span de dibujos			17		17
Búsqueda de símbolos					7
Letras y números		18			
Aritmética	9				
Suma de puntuaciones escalares	18	31	71	46	47

Raz. Cuantitativo Mem. Trabajo auditivo No verbal Capacidad General Competencia Cognitiva

IRC	IMTA	INV	ICG	ICC
91	130	114	95	113



Conversión de suma de puntuaciones escalares a índices					
Escala	Suma puntuaciones escalares	Índice		Rango Percentil	Intervalo de confianza
					95%
Razonamiento Cuantitativo	17	IRC	91	27	84-99
Memoria de trabajo auditiva	31	IMTA	130	98	120-135
No verbal	71	INV	114	82	107-120
Capacidad general	46	ICG	95	37	89-102
Competencia cognitiva	47	ICC	113	81	104-120

CENTRO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGÍA, ASISTENCIA INTEGRAL Y REHABILITACIÓN

DIR: CALLE 11 # 11 – 07 BARRIO SAN JOAQUÍN LOCAL 102

CONTACTOS: 312 567 8078 – prascacenter@gmail.com

INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES SECUNDARIOS

Razonamiento cuantitativo

El valor obtenido en IRC de 91 (entre 84-99) se sitúa en el percentil 17 y se clasifica como punto fuerte normativo / Promedio con relación a otros niños de su edad y escolaridad.

El índice de Razonamiento cuantitativo refleja la capacidad para realizar operaciones matemáticas mentalmente y comprender las relaciones cuantitativas. Se ha evaluado mediante dos tareas: en la primera se le pidió resolver mentalmente problemas aritméticos (Aritmética, Pe = 9) y en la otra se le pidió que observe una balanza a la cual le faltan pesas y seleccionar la opción que la mantiene equilibrada (Balanzas, Pe = 9). La variabilidad de los resultados en estas tareas no es representativa (es decir, que su amplitud es menor a 5 puntos), punto fuerte normativo en este tipo de razonamiento.

Memoria de trabajo auditiva

El valor obtenido en IMTA de 130 (entre 120-135) se sitúa en el percentil 31 y se clasifica como Muy superior / fuerte normativo con relación a otros niños de su edad y edad escolar.

El índice de Memoria de trabajo auditiva indica la aptitud para registrar, mantener y manipular información presentada verbalmente. Se ha evaluado mediante dos tareas: en la primera se le pidió repetir una lista de cifras en el mismo orden o en orden inverso (Dígitos, Pe = 13) y en la otra se le solicitó repetir una combinación de letras y números leída previamente por el/la entrevistador/a (Letras y números, Pe = 18). La diferencia de los resultados entre las dos tareas es grande (llega a los 5 puntos) y sugiere que el resultado en IMTA es una habilidad en lo relacionado a la memoria de trabajo auditiva.

No verbal

El valor obtenido en INV de 114 (entre 107-120) se sitúa en el percentil 82 y se clasifica como Punto fuerte normativo / Promedio alto con relación a otros niños de su edad en la población normal.

El índice no verbal puede interpretarse como una medida de aptitud intelectual general que reduce al mínimo la intervención del lenguaje expresivo. El INV está conformado por 6 puntuaciones escalares de pruebas que no requieren respuestas verbales: cubos (Pe = 14), matrices (Pe = 9), claves (Pe = 10), balanzas (Pe = 9), puzles visuales (Pe = 12) y span de dibujos (Pe = 17). La variabilidad de los resultados en estas tareas es inusualmente grande (es decir, su amplitud es igual o mayor que 5 puntos), punto fuerte normativo en este tipo de razonamiento.

Capacidad general

El valor obtenido en ICG de 95 (entre 89-102) se sitúa en el percentil 37 y se clasifica como Punto fuerte normativo / Promedio con relación a otros niños de su edad en la población normal.

El índice de capacidad general hace referencia a una estimación de la aptitud intelectual general menos dependiente de la memoria de trabajo y de la velocidad de procesamiento que el CI total. Involucra la capacidad de razonamiento abstracto y conceptual, razonamiento visoperceptivo y espacial y resolución de problemas verbales. El ICG es el resultado de 5 puntuaciones escalares: cubos (Pe = 14), semejanzas (Pe = 6), matrices (Pe = 9), vocabulario (Pe = 8) y balanzas (Pe =



9). La variabilidad de los resultados en estas tareas es inusualmente grande (es decir, su amplitud es igual o mayor que 5 puntos), punto normal normativo en este tipo de razonamiento.

Competencia cognitiva

El valor obtenido en ICC de 113 (entre 104-120) se sitúa en el percentil 81 y se clasifica como Promedio alto/ punto fuerte normativo, con relación a otros niños de su edad y escolaridad.

El índice de competencia cognitiva ofrece una estimación de la eficacia con la que se procesa la información durante el aprendizaje, la resolución de problemas y el razonamiento de nivel superior. El ICC es el resultado de 4 puntuaciones escalares: dígitos (Pe = 13), claves (Pe = 10), span de dibujos (Pe = 17) y búsqueda de símbolos (Pe = 7). La variabilidad de los resultados en estas tareas es inusualmente grande (es decir, su amplitud es igual o mayor que 5 puntos), punto fuerte normativo en este tipo de razonamiento.

COMPARACIONES ENTRE ÍNDICES PRIMARIOS

Del cuadro de comparaciones entre puntuaciones se extraen diferencias significativas al 95% entre los siguientes pares de puntuaciones:

Comprensión verbal < Razonamiento fluido: Implica adecuadas respuestas en las aptitudes fluidas con respecto a las cristalizadas.

Comprensión verbal < Memoria de trabajo: Implica punto fuerte en la capacidad de identificar y registrar información en la memoria a corto plazo sobre el uso de estímulos verbales para la resolución de problemas.

Comprensión verbal < Velocidad de procesamiento: Indica punto debilitado en la velocidad para tomar decisiones utilizando información presente en la memoria a corto plazo respecto al uso de los estímulos verbales para resolver problemas.

Visoespacial < Velocidad de procesamiento: Refleja debilidades en la velocidad para tomar decisiones utilizando información presente en la memoria a corto plazo respecto a la capacidad de comprender y utilizar información visoperceptiva/visoespacial.

Razonamiento fluido < Velocidad de procesamiento: Sugiere capacidades inferiores en la velocidad para tomar decisiones utilizando información presente en la memoria a corto plazo respecto a las aptitudes para entender la relación entre la información visual y los conceptos abstractos.

Memoria de trabajo < Velocidad de procesamiento: Establece bajas competencias en la toma de decisiones rápidas utilizando la información registrada en la memoria a corto plazo operativa, pero con alta manipulación de la información de forma simbólica y numérica.

COMPARACIONES ENTRE ÍNDICES SECUNDARIOS

Del cuadro de comparaciones entre puntuaciones se extraen diferencias significativas al 95% entre los siguientes pares de puntuaciones:

Capacidad general < Competencia cognitiva: Indica que las aptitudes que favorecen la eficacia del procesamiento cognitivo (memoria de trabajo y velocidad de procesamiento) pueden ser un



punto intermedio en el manejo de información, con las aptitudes cognitivas de nivel superior (comprensión verbal, procesamiento visoespacial y razonamiento fluido).

ANORMAL: Memoria de trabajo < Memoria de trabajo auditiva: Se observó que la presentación verbal de la información establece un nivel superior en el funcionamiento de la memoria de trabajo respecto a la presentación visual.

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS PRUEBAS

Del cuadro de comparaciones entre puntuaciones se extraen diferencias significativas al 95% entre los siguientes pares de puntuaciones:

SUPERIOR: Cubos > Puzles visuales: Indica que el aprendizaje procedimental, la resolución de problemas por ensayo-error, el feedback visual concreto y/o la integración visomotora favorecen el rendimiento en tareas en las que interviene el razonamiento visoperceptivo y espacial.

NORMAL: Matrices < Balanzas: Las actividades relacionadas con el razonamiento cuantitativo se establece como punto normal respecto al razonamiento inductivo.

ANORMAL: Claves < Búsqueda de símbolos: Sugiere que el rastreo visual poco efectivo es una fortaleza respecto a la memoria asociativa y/o la velocidad grafomotora.

SUPERIOR: Balanzas > Aritmética: Designa altas respuestas de aptitud de razonamiento cuantitativo cuando el estímulo y la respuesta son visuales, en vez de verbales.

SUPERIOR: Retención de dígitos < Letras y números: Indica respuestas por encima del promedio con tareas que impliquen de ordenar cadenas largas de números.

Evaluación Neuropsicológica

ATENCIÓN		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
EJECUCION AUDITIVA CONTINUA	16/15.20 Errores: 0	[NORMAL]
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
EJECUCION VISUAL CONTINUA	16/15.20 Intrusión: 0	[NORMAL]
Mide las respuestas en la velocidad de procesamiento y efectividad de las respuestas, establece datos normativos de los procesos atencionales: atención focalizada, sostenida y alternante. Errores ejecutivos: errores de omisión, errores perseverativos, distribución de los recursos atencionales a diferentes tareas o requisitos de una misma tarea.		



TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
TMT A	Puntuación: 24/24 Tiempo: 125/28,99	[NORMAL] [ANORMAL] SD 12,74 – SD -+4
Evalúa las habilidades motoras, viso-espaciales de búsqueda visual y atención sostenida.		
ATENCIÓN EJECUTIVA		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
TMT B	Puntuación: 24/24 Tiempo: 184/49,81	[NORMAL] [ANORMAL] SD 29,35 – SD - +4
Mide la velocidad de procesamiento, rastreo visual, atención alternante, divida, sostenida, flexibilidad mental del pensamiento, habilidades visoespaciales.		
ORIENTACIÓN AUTO Y ALOPSÍQUICA		
ESCALA DE MEMORIA WECHSLER		
SUB-PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
INFORMACION	5/5.70	[NORMAL]
ORIENTACION	5/5	SD 0 – SD [NORMAL]
Mide la orientación alopsíquica y autopsíquicas, si existe alteración en los dos procesos existe alteración global de la orientación.		
MEMORIA DE TRABAJO		
CONTROL MENTAL	9/6.2	SD 1.90 – SD [NORMAL]
Se relaciona con los procesos de la memoria de trabajo, operaciones mentales en línea a corto plazo, memoria semántica, velocidad de respuesta manteniendo la atención sin interferencia.		
DIGITOS	5/9,6	5/9,6 [NORMAL]
Establece medida de los procesos atencionales que requieren esfuerzo cognitivo, memoria de trabajo, memoria inmediata, indicando habilidades de secuenciación, planificación, alerta y flexibilidad cognitiva, span verbal y auditivo.		
MEMORIA A CORTO Y LARGO PLAZO DE CONTENIDO AUDITIVO VERBAL		
MEMORIA LOGICA	14/12,6	SD 2.52 [NORMAL]
Mide la memoria sensorial ecoica, capacidad de registro, almacenamiento y evocación, capacidad en la memoria a corto plazo, capacidad de aprendizaje, habilidad auditiva verbal, capacidad de almacenamiento semántico, span de memoria, capacidad de relación lógica, información organizada.		



MEMORIA LOGICA DIFERIDA	14/12,3	[NORMAL]
CURVA DE MEMORIA VERBAL	Inmediato 9/6.5 Diferido 12/6.0 Recordatorio 11/0,5	[NORMAL] – SD – 1.7 [NORMAL] – SD – 1.8
Tiempo requerido para almacenar y evocar información con relación semántica, evocación verbal a corto y largo plazo. Capacidad de aprendizaje. (recuerdo, perseveraciones, diferentes tipos de intrusiones y falsos positivos).		
MEMORIA A CORTO Y LARGO PLAZO DE CONTENIDO VISUAL		
REPRODUCCION VISUAL	12/9,6	[NORMAL]
Evalúa la capacidad de los recuerdos inmediato de estímulos visuales, capacidad de atención sostenida, focalizada, memoria que almacena o retiene información perceptiva, en este caso visual, para trabajar con ella, capacidad de organización y dar sentido a las cosas.		
REPRODUCCION VISUAL DIFERIDA	11/8,4	[NORMAL]
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
Figura De Rey evocación	Puntuación: 22/19,23 Tiempo: 165/116,30	[NORMAL] SD 5,96 [NORMAL] SD 54,95
Brinda información sobre el funcionamiento neuropsicológico. Evalúa los procesos de registro, almacenamiento y evocación de memoria a largo plazo. Capacidad de aprendizaje general memoria visual – organización.		
PRAXIAS		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
Figura De Rey copia	Puntuación: 35/30,74 Tiempo: 215/166,24	[NORMAL] SD 4,32 [NORMAL] SD 52,60
Evalúa la organización perceptual y la memoria visual, rastreo visual, atención sostenida – focalizada, organización perceptual. Praxias viso construccionales.		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
PRAXIAS CORPORALES (IDEACIONALES)	20/20	[NORMAL]
PRAXIAS CORPORALES (IDEOMOTORAS)	40/40	[NORMAL]



FLUIDEZ VERBAL		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
FAS FONOLÓGICO	7/29,1	SD 7,8 [ANORMAL] - SD - 2
Mide la habilidad de producción de palabras que inician con una letra o fonema y el aspecto semántico dentro de una categoría semántica determinada. Evaluación global del lenguaje y funciones ejecutivas, funciones cognitivas.		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
FAS SEMANTICO	41/30,3	SD 6,6 [NORMAL]
Evalúa la flexibilidad mental, la velocidad de procesamiento y el lenguaje. Pone a prueba los mecanismos necesarios para el acceso al léxico, evocación y denominación.		
FUNCIONES EJECUTIVAS		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
TOKEN TEST	36/35,0	[NORMAL] SD 1.0
Evalúa la comprensión de ordenes de baja, mediana (dos comandos) y alta complejidad (tres comandos). Comprensión de ordenes con capacidad creciente. Evalúa la comprensión los verbos y las preposiciones incluidos en las instrucciones, sintaxis.		
PRUEBA DE CLASIFICACIÓN DE WISCONSIN		
Evalúa el razonamiento abstracto, estrategias de solución de problemas necesarias para lograr un objetivo, funciones ejecutivas, cambio de tarea, la flexibilidad cognitiva, la actualización, la inhibición, la planificación o la fluidez, mantenimiento del principio.		

WCSTw: Resultados

Indica "n° ítem: tecla pulsada/Acierto(+) o Error(-)/Respuesta según Color, Forma,..."

W.C.S.T. A. Estévez-González, 2001

Datos Personales

LUIS GABRIEL ZUBIRIA
 Fecha : 30/08/25
 Sexo : v
 Edad : 13 años
 Lateralidad : Diestro/a
 Escolaridad : 8 años
 Observaciones no especificadas

Resultados

INTENTOS Utilizados.....: 128
 ACIERTOS Totales.....: 90
 ERRORES Totales.....: 38 (29%)
 Errores Perseverativos...: 13 (10%)
 Errores NoPerseverativos: 25 (19%)
 Respuestas Conceptuales : 83 (64%)
 CATEGORIAS.....: 5
 N° Intentos 1ª categoría: 13
 Errores Manten. del Set : 3
 Aprendiendo a Aprender : -1
 Tiempo medio respuesta : 1751 msec.

Características de la prueba

WCST clásico con secuencia CFND
 N° Estímulos Prueba : 128

Imprimir Grabar Finalizar

ADOS 2**Autism Diagnostic Observation Schedule, Segunda Edición****ALGORITMO DIAGNÓSTICO: MODULO 3: FLUIDEZ VERBAL****Afectación social (AS)****Comunicación**

Narración de sucesos	(A-7)	2	2
Conversación	(A-8)	3	2
Gestos descriptivos, convencionales, instrumentales o informativos	(A-9)	2	2

Interacción social recíproca

Contacto visual inusual	(B-1)	2	0
Expresiones faciales dirigidas al examinador	(B-2)	1	1
Disfrute compartido durante la interacción	(B-4)	2	2
Características de las iniciaciones sociales	(B-7)	1	1
Calidad de respuesta social	(B-9)	3	2
Cantidad de comunicación social recíproca	(B-10)	1	1
Calidad general de la relación	(B-11)	2	2

TOTAL AS**15****Comportamiento restringido y repetitivo (CRR)****Comportamientos restringidos y repetitivos**

Uso estereotipado o idiosincrásico de palabras o frases	(A-4)	1	1
Interés sensorial inusual en los materiales de juego o en las personas	(D-1)	2	2
Manierismo de manos y dedos y otros manierismos complejos	(D-2)	0	0
Intereses excesivos en temas u objetos inusuales o altamente específicos	(D-4)	0	0

TOTAL CRR**3****PUNTUACIÓN TOTAL GLOBAL (AS + CRR)****18**

CONVERSIÓN DE LA PUNTUACIÓN TOTAL GLOBAL AL RANGO DE PREOCUPACIÓN DEL ADOS-2	
Rango de preocupación	Puntos de corte
Rango Cuantitativo	18
Rango Cualitativo	Autismo

Durante la evaluación se observó que al paciente le costó proporcionar información acerca de hechos rutinarios o no rutinarios en su vida diaria, aun con preguntas específicas el paciente no logro de forma contingente dar respuestas a lo tratado; el paciente mostro poca habla comunicativa espontánea, puede conversar de temas que son de su interés sin embargo el uso del contacto visual es muy limitado, no se observó atención conjunta, al igual que gestos espontáneos informativos convencionales o instrumentales, con uso excepcional o ningún uso de gestos descriptivos.

El paciente presento muy baja facilidad de contacto, tiene poca apertura cognitiva, se mostró poco flexible, presionado, le cuesta establecer una interacción funcional, en momentos se vio sonriente con la madre pero sin establecer una conversación fluida con el uso del material del ADOS 2.

En la tarea de construcción el paciente no logro seguir la instrucción toma las piezas para formar una figura pero no era capaz de dirigirse al evaluador o comunicar su interés, le costó comunicarse de forma espontánea, las preguntas que respondió fueron guiadas con alto nivel de musicación.

Por ejemplo en la tarea de narración de suceso a partir de un cuento no logro evocar información relacionada a lo observado, solo se centró en ver las imágenes pero sin evocar palabra, aun con apoyo y modelamiento no logro hacerlo.

Por momentos se tornó angustiado, con alta labilidad emocional, con alta expresión hiponímica.

En las tareas de juego simbólico se observó interés inusual por algunos juguetes pero sin evocar palabras relacionadas, no logro imitar o seguir los simbolismo dado por el evaluador; la atención conjunta estuvo limitada.



El paciente no mostro iniciaciones espontaneas en los días de evaluación, respondiendo algunas preguntas estructuras de la escala ADOS 2, como sentirse rechazado o no comprendido en su grupo de amigos con mayor preferencia por amigas, prefiriendo la interacción virtual con video juegos de manera particular con el juego roblox; agrego que en ocasiones quisiera integrarse pero no puede, lo piensa pero no logra decirlo, otras veces le parece innecesario hablar de los temas que hablan los demás amigos.

El menor expreso que antes no se la llevaba con su padre porque lo ignoraba, lo cual ha cambiado sin embargo se muestra poco flexible a la interacción.

Expreso que le molestan los ruidos, que en ocasiones se aleja del lugar o se tapa los odios, motivado por tronarse los dedos de forma reiterada.

Su porte y actitud es inadecuado, con tendencia a caminar en puntas aunque no lo hace, lo que hace que su locomoción sea poco integrada, con baja reciprocidad socio emocional, prefiriendo estar en casa la mayor parte del tiempo antes que salir a lugares donde hay muchas personas.

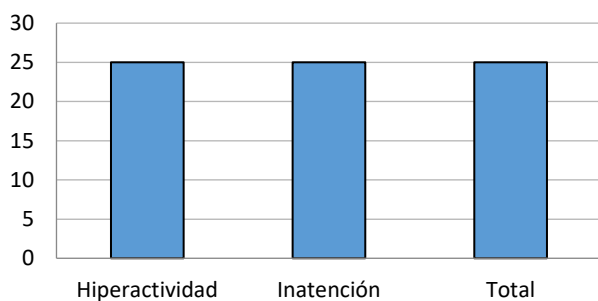
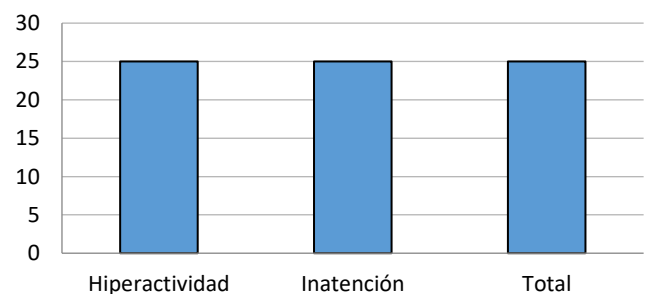
ESCALAS

Escala de Autismo Infantil (C.A.R.S.)	
Preguntas de la prueba	
I. REFERENTE A LA GENTE	4
II. IMITACION	1
III. RESPUESTA EMOCIONAL	1
IV. USO DEL CUERPO	1
V. USO DE OBJETOS	1
VI. ADAPTACION AL CAMBIO	1
VII. RESPUESTA VISUAL	1
VIII. RESPUESTA AUDITIVA	1
IX. RESPUESTA AL SABOR, OLOR, TACTO Y USO	2
X.MIEDO O NERVIOSISMO	2
XI. COMUNICACION VERBAL	4
XII. COMUNICACION NO VERBAL	1
XIII. NIVEL DE ACTIVIDAD	1
XIV. NIVEL Y CONSISTENCIA DE LA RESPUESTA INTELECTUAL	1
XV. IMPRESIONES GENERALES	1



RESULTADOS DE LA ESCALA DE AUTISMO INFANTIL (C.A.R.S)
RESULTADO: 23 No riesgo para autismo

RESULTADOS DEL TDAH 5 HOGAR ADOLESCENTE				RESULTADOS DEL TDAH 5 ESCUELA ADOLESCENTE			
ESCALA	PB	PERCENTIL	CLINICAMENTE	ESCALA	PB	PERCENTIL	CLINICAMENTE
Hiperactividad	0	25	DESCARTAR	Hiperactividad	1	25	DESCARTAR
Inatención	5	25	DESCARTAR	Inatención	7	25	DESCARTAR
Total	5	25	DESCARTAR	Total	8	25	DESCARTAR
DETERIORO		PERCENTIL	CLINICAMENTE	DETERIORO	PB	PERCENTIL	CLINICAMENTE
Relaciones con los padres	2	99	MODERADO	Relaciones con el maestro	1	85	LEVE
Relaciones con los pares	2	99	MODERADO	Relaciones con los pares	2	98	MODERADO
Tareas	2	98	MODERADO	Tareas	2	90	MODERADO
Desempeño Académico	1	85	LEVE	Desempeño Académico	1	70	LEVE
Conducta	1	90	LEVE	Conducta	0	40	NINGUNO
Autoestima	1	93	LEVE	Autoestima	1	25	LEVE

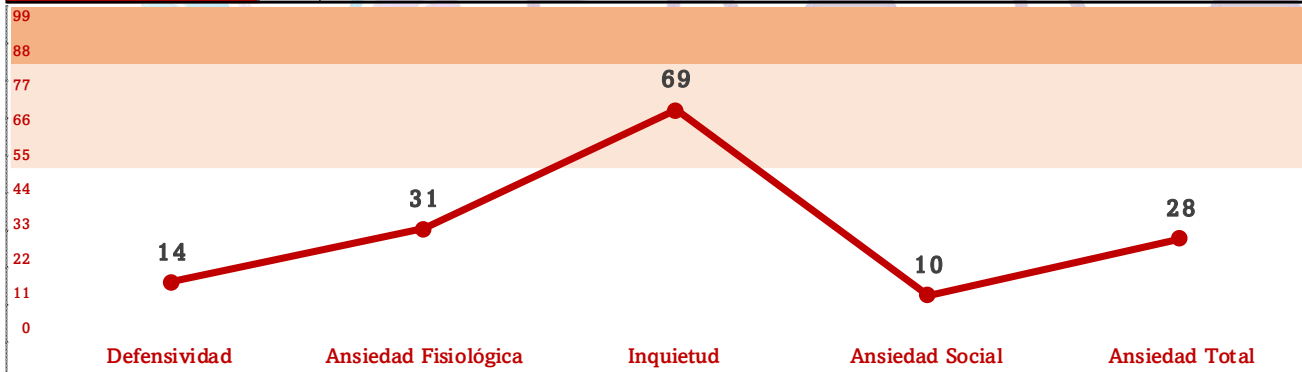
TDAH 5 HOGAR ADOLESCENTE

TDAH 5 ESCUELA ADOLESCENTE


Criterios cumplidos para el diagnóstico de trastorno del espectro del autismo DSM 5	
Criterio a: Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes.	
Deficiencias en la reciprocidad socioemocional	
Deficiencias en acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos.	
Disminución en intereses, emociones o afectos compartidos	
Comunicación verbal y no verbal poco integrada pasando por anomalías del contacto visual	
Deficiencias de la comprensión caracterizada por fuga de ideas	
Dificultad en el mantenimiento y comprensión de las relaciones.	X
Existen poco interés por otras personas.	
B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por los antecedentes.	
Estereotipias motoras simples, como jugar con las manos y mover la cabeza.	
Disprosodia	
frases idiosincrásicas, es decir palabras que tienen un significado inusual o raro	
Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas, patrones de pensamiento rígidos.	X
Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés	
Hiper- o hiporeactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno	
Criterio: Si cumple por lo menos dos criterios en el ítem A y B, se establece un alto riesgo para autismo.	



CMASR-2

Escala	Baremos			Categoria Dx	Masculino 9 a 14 años
	PD	PT	PC		Interpretación
Defensividad	3	39	14	Bajo	es sincero (a) para responder a los reactivos
Ansiedad Fisiológica	10	45	31	Leve	experimenta de manera leve aspectos somáticos como náuseas, dificultades de sueño, dolores de cabeza y fatiga.
Inquietud	7	55	69	Moderado	experimenta sentimientos Moderados de temor a ser lastimado, nervioso, hipersensible a las presiones del entorno, internaliza gran parte de la ansiedad que experimenta, puede sentirse abrumado al tratar de aliviar la ansiedad.
Ansiedad Social	4	37	10	Bajo	no presenta indicadores de ansiedad social.
Ansiedad Total	21	44	28	Leve	Leve
Inconsistencia	3				Valido.



LUIS GABRIEL ZUBIRIA QUIÑONEZ manifiesta una ansiedad general PT 44 que indica alteración Leve, dentro las escalas se pueden observar que la Defensividad, PT 39, indica que es sincero (a) para responder a los reactivos, en la escala de Ansiedad Fisiológica PT 45, indica que experimenta de manera leve aspectos somáticos como náuseas, dificultades de sueño, dolores de cabeza y fatiga. Inquietud PT 55, indica que experimenta sentimientos Moderados de temor a ser lastimado, nervioso, hipersensible a las presiones del entorno, internaliza gran parte de la ansiedad que experimenta, puede sentirse abrumado al tratar de aliviar la ansiedad. Ansiedad Social PT 37 indica que no presenta indicadores de ansiedad social. Por último en la escala de Inconsistencia obtuvo un PD de 3 por lo que, la prueba es Válida.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Resultados de evaluación:

ORIENTACIÓN: Adecuada orientación auto y alopsíquica.

ATENCIÓN: Presenta un desempeño adecuado en la atención focalizada, sostenida, selectiva (no distractiva) acorde a su edad y escolaridad, la atención focalizada le permite mantenerse en un estímulo relevante independientemente del tiempo, la atención sostenida le permite la capacidad de mantener el foco en una actividad o estímulo durante un tiempo determinado, la atención selectiva le permite establecer la capacidad de focalizar la mente en un estímulo o una tarea concreta, sin permitir que otros estímulos interrumpen lo que se está haciendo.

Presenta adecuada atención auditiva, adecuada búsqueda organizada de los estímulos, aunque con una inadecuada velocidad en la ejecución de tareas que se deben ejecutar en un tiempo específico.

Paciente con adecuada capacidad de esfuerzo en la ejecución de tareas no motivantes, prestando atención a los detalles, se esfuerza y dirige la conducta, inhibiendo los estímulos irrelevantes, mantiene la concentración aun cuando el grado de la tarea aumenta, es capaz de regular su comportamiento, aunque no logra mantener una adecuada posición sedente, con agitación motora, impulsividad.

MEMORIA: Presenta adecuada memoria ecoica e icónica, la memoria de trabajo y la memoria acorto y largo plazo de contenido verbal y visual presentan un desempeño por encima de lo esperado para la edad y escolaridad. Esto quiere decir, que existe facilidad para mantener información dando una respuesta posterior, es posible que esto se vea afectado en los casos que el paciente no quiera comunicarse o este afectado su estado de ánimo.

Su capacidad de memoria o spam es de 10 sobre 10, observándose de forma correcta el efecto de primacía y recencia, no se observaron intrusiones, perseveración, intrusiones, con adecuada organización serial.

LENGUAJE: Existe inadecuada capacidad semántica, de vocabulario, existe inadecuado seguimiento de instrucciones, le cuesta la comprensión (capacidad de entender y procesar el lenguaje hablado y/o en doble vía, manteniendo una comunicación poco efectiva con baja fluencia lingüística en la producción oral, tendencia a la disprosodia, musitación.

No se observaron problemas articulatorios, nasalización, hipofonia, parafasias semánticas, fonológicas o visuales.

Lectura: Existe adecuada eficiencia lectora, lo que quiere decir que existe adecuada conversión grafema - fonema, con identificación adecuada de las palabras para la recuperación de su pronunciación.



No se observaron sustituciones como lexicalización, con adecuado uso de literales, no se observaron omisiones de la letra o inadecuado uso de segmento.

Escritura: Existe adecuado lenguaje escrito, con normales respuestas en los procesos de segmentación fonética y recuperación de los grafemas de cada palabra y la destreza manual necesaria para la escritura aunque con tendencia a la disortografía.

PRAXIAS VISO CONSTRUCCIONALES: Se identifica nivel normal para la edad y escolaridad en lo que se refiere a la copia de modelos a través del sistema grafo motor, coordinación viso motora y proceso viso perceptuales. No se observa dificultad en el proceso para el manejo de proporciones, detalles de la imagen, integración de los elementos, exactitud, sin omisión de los elementos.

GNOSIAS: No se observan alteraciones en el reconocimiento de la información previamente aprendida a través de nuestros sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto.

FUNCIONES EJECUTIVAS: Cribado quien se muestra inseguro, con dificultades en la capacidad de abstracción, poca espontaneidad, pocas habilidades sociales, inadecuadas habilidades de afrontamiento, con alta musitación y tendencia al mutismo selectivo, poca flexibilidad, aunque con alta capacidad en la memoria de trabajo, algunas dificultades para mantener el principio, seguir una secuencia, bajas respuestas en toma de decisiones y conducta adaptativa.

Paciente con **CIT de 99**, lo que lo ubica en un rango de acuerdo con el WISC V con **capacidad general intelectual promedia**, sin embargo, las bajas puntuaciones en comprensión verbal, funciones ejecutivas, adaptación, comunicación e interacción pueden hacer que sea necesario la necesidad de adecuación y adaptación curricular en las aulas escolares, ya que esto puede limitar el aprovechamiento y rendimiento académico en el aula escolar sobre todo cuando se debe efectuar el lenguaje.

Se observa inadecuado desarrollo de la capacidad cognoscitiva en la comprensión verbal 84 y habilidades visoespaciales de 117, lo cual establece una alteración del desarrollo del hemisferio cerebral derecho en comparación con el desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo con una diferencia de 33 puntos. Esto establece la necesidad de estimulación como estrategia que permita un progreso equilibrado de los procesos cognoscitivos.

Se observan respuestas dentro del promedio esperado en cuanto al procesamiento de la información con sus recursos innatos, del indicador de razonamiento fluido.94, lo que facilita en la paciente la capacidad de resolver nuevos problemas de forma inmediata, es decir, de forma instintiva y con destreza.

La memoria de trabajo, 127, se encuentran dos rangos por encima promedio, facilitando el manejo de la información a corto, plazo, en línea, siendo un punto fuerte normativo en el desarrollo académico y habilidades intelectuales.



La velocidad de procesamiento, 92, se encuentran en el rango promedio, lo que puede establecer facilidad en las respuestas de forma rápida, efectiva y sin interferencia, punto fuerte normativo en el desarrollo académico y habilidades intelectuales

Perfil del paciente:

Según la aplicación de las pruebas y observación clínica se obtiene un perfil de capacidad intelectual promedio, con rasgos de ansiedad leves con mayores respuestas psicosomáticas y de hipersensibilidad, con alteración en comprensión verbal, lo que dificulta el análisis, síntesis, razonamiento, abstracción, con un alto desarrollo en el desarrollo manipulativo, con adecuada capacidad de aprendizaje, aunque con algunas dificultades en el aprendizaje auditivo verbal de alta complejidad que implica un nivel elevado de razonamiento; la capacidad de memoria de trabajo se encuentra por encima de lo esperado con facilidad para la codificación, decodificación y evocación de la información, se le facilita el manejo de la información en línea y de forma simbólica, lo cual compensa por ejemplo las dificultades en la comprensión, el tiempo de ejecución y procesamiento de la información dependerá en gran medida de la cualidad y la intensidad del estímulo, así como los intereses intrínsecos del paciente; el paciente tiene una alta capacidad de escucha, sin embargo durante los tiempos evaluativos el paciente no logra comunicarse de forma espontánea aun en presencia de la madre, se evidencio poca facilidad de contacto, con afecto plano y tendencia a la angustia, le costó mantener una conversación fluida con el evaluador, fue capaz de responder preguntas dirigidas pero no tomar la iniciativa sobre temas que no sean de su interés, con interés inusual propioceptivo, se observo dificultades para iniciar, mantener una conversación, le costo crear historias de forma espontánea, aun con ayuda del evaluador no logra realizarla, se resalta que el uso por ejemplo de apoyo visual como viñetas, mapas, libros no logra evocar información relacionada; durante la evaluación el paciente no comunico sus intereses con alto apego por la madre, lo cual favoreció a que su desempeño cognitivo sea adecuado, logrando reírse pero no mejorando la comunicación pragmática.

Existe una tendencia al mutismo selectivo, con alto nivel de musitación (hablar para sí mismo sin un lenguaje claro o difícil de escuchar para el receptor), existe bajo desarrollo de habilidades sociales, bajas respuestas en la toma de decisiones y adaptación a diferentes contextos, con disprosodia (acento inusual como si fuera personaje de caricatura de gravedad leve).

El cribado presenta conducta monótona, excesiva inflexibilidad de rutinas, patrones de pensamiento rígidos, con dificultad en el mantenimiento y comprensión de las relaciones, muestra baja reciprocidad socio emocional, prefiriendo estar en casa la mayor parte del tiempo antes que salir a lugares donde hay muchas personas, en ocasiones siente que no encaja, puede sentirse excluido, guardando silencio, expreso en algún momento que piensa las cosas pero no logra decirlas. No fue posible observar de forma funcional el juego simbólico, la atención conjunta, con pocos gestos integrados (hiponimia).



En las listas de chequeos de los docentes, al igual que los relatorio, describen selectividad para la interacción, se observó hiporeactivo, dificultades en las relaciones con docentes, marcada dificultad en las relaciones con pares académicos, con dificultades en la autoestima, lo cual se evidencia en la lista de chequeo de los padres caracterizada por limitaciones en las relaciones con padres y pares.

El paciente refiere le molestan los ruidos, que en ocasiones se aleja del lugar o se tapa los odios, motivado por tronarse los dedos de forma reiterada. Presenta inadecuado porte y actitud con tendencia a caminar en puntas lo que hace que su locomoción sea poco integrada.

El paciente presenta una tendencia disortografía en la escritura lo que puede hacer que lagunas personas se les dificulte entender el mensaje, no significa que existan criterios para una disgrafía.

El nivel de inteligencia adecuada, con un nivel de competencia cognitiva por encima de lo esperado, con un alto nivel de memoria de trabajo, spam de memoria, no se relaciona con las afectaciones en comunicación, interacción, socialización, con un patrón de comportamiento restrictivo, lo cual constituye un alto riesgo para el espectro del autismo con nivel de apoyo grado 1.

COMPRESIÓN VERBAL: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

VISOESPACIAL: PROMEDIO ALTO

RAZONAMIENTO FLUIDO: PROMEDIO

MEMORIA DE TRABAJO: SUPERIOR

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: PROMEDIO

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

CIE 10 F845 SÍNDROME DE ASPERGER (Nivel de apoyo grado 1 – DSM 5), Equivalente a la CIE 11 - 6 A02.0 Trastorno del Espectro del Autismo sin Trastorno del Desarrollo Intelectual con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje.

CIT DE 99, CAPACIDAD GENERAL INTELECTUAL PROMEDIO.

PLAN DE TRATAMIENTO

Consulta control por neuropsicología en tres meses.

Rehabilitación neuropsicológica 2 veces por semanas por dos meses para fortalecer los procesos cognitivos para mejorar flexibilidad, espontaneidad, interacción, disprosodia, pensamiento rígido, comprensión, atención conjunta, narrativas, abstracción, entender diferentes puntos de vista.



Rehabilitación dos veces por semana por tiempo de 6 meses desde psicología que permita abordar seguridad, confianza, desarrollar habilidades en la resolución de problemas, razonamiento ético; adopción de perspectiva, desarrollo de asertividad; interacción en doble vía, inoculación de estrés; ansiedad, auto instrucciones; habilidades de afrontamiento; autocontrol y control emocional; cognitivo-conductuales educación afectiva; entrenamiento en habilidades sociales.

Rehabilitación desde terapia ocupacional para abordar intereses propioceptivos, hiperresponsividad, flexibilidad, interacción, socialización, comunicación espontanea, atención conjunta, intereses restrictivos.

Realizar adecuación y adaptación curricular: Implementación del plan Individual de apoyos y ajustes razonables (PIAR) [Subsección 3 Esquema de atención educativa - Artículo 2.3.3.5.2.3.5], por parte de la institución educativa, que permita favorecer el proceso de avance del - la niña(o) en sus aprendizajes escolares, y fomentar la motivación hacia los mismos. Lo anterior implica ajustar los logros y competencias al nivel del - la niña(o), estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo en el transcurso del grado escolar que curse y mecanismos que permitan potencializar los aprendizajes mediante diferentes estrategias de evaluación de contenidos y logros acordes a sus capacidades y no las del grupo exclusivamente.

Proporciónale tareas más complejas o proyectos que estimulen su pensamiento crítico y creatividad.

Bríndale oportunidades para explorar temas de su interés y trabajar de manera independiente cuando sea apropiado.

Anima a que profundice en los temas, en lugar de solo memorizar información, promoviendo el análisis y la reflexión verbal con apoyo en lo escrito y dibujos.

Integra actividades que desafíen su nivel, como debates, investigaciones o proyectos innovadores, no la presione, no la minimice, resalta lo positivo.

Reconoce sus logros y ayúdale a gestionar posibles sentimientos de aburrimiento o frustración si no encuentra suficiente estímulo.

Esto puede ayudarle a desarrollar habilidades sociales y a compartir ideas con pares que tengan intereses similares – por favor psicoedúque a los otros niños la integren cuando se aislé, promoverá el desarrollo de habilidades sociales y hará de sus compañeros mejores seres humanos.

Trabaja con docentes especializados en educación para altas capacidades relacionas con la memoria y para el desarrollo de la comprensión verbal, que permitan diseñar estrategias personalizadas.



Dar un trato digno, se debe generalizar también para los estudiantes, no es necesario decir que existe una condición, exprese que se le dificulta la interacción.

Necesidad de orientación educativa en los días que este más aislado y ansioso.

Implementar metodología de aprendizaje personalizado y acordes a sus capacidades que incluyan el apoyo visual auditivo como YouTube.

Es importante verificar si desde su asignatura comprendido la explicación, recuerde que lo que mas se le dificulta es la parte comprensiva y de comunicación.

Promueva la participación en clase permanente con puntos extras.

Realizar actividad física o musical que permita mejorar los procesos manipulativos y habilidades sociales.

Trate de comprender el comportamiento, no se lo tome personal.

Utilice un lenguaje claro, mensaje corto y apoyo en lo visual y auditivo.

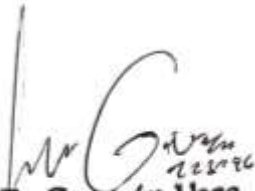
Refuerce las conductas positivas, sobre todo las de interacción y espontaneidad.

Siente cerca al docente para tener chance de explicar o hacer aclaraciones a temas que se le puede dificultar.

Evite criticar su comportamiento, anímelo sin criticar, no se lo tome personal.

Coloque actividades de monitor, esto ayudara a mejorar la interacción.

No permita que le hagan matoneo, esto puede desfavorecer la autoestima, la interacción.



Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096
U.S.B. - Medellín

Firma

Nombre del Profesional: Jainer Guzmán Vega

Especialidad: M.G Neuropsicología – Universidad San buenaventura de Medellín

No. Tarjeta Profesional:123096

Certificado internacional en ADOS 2

